

"TECNICAS PSICOMETRICAS B"

EVALUACION EN PASICOLOGIA EDUCACIONAL

- Estudia **CONSTRUCTOS PSICOLÓGICOS** relevantes en los **procesos de enseñanza y aprendizaje**.

Estos constructos **también se evalúan en otros ámbitos (psicología laboral, sanitaria, etc.)**, pero en **educación son fundamentales** para **COMPRENDER Y MEJORAR** el aprendizaje.

"NO SE PUEDE aplicar ni interpretar adecuadamente una prueba **SI NO SE CONOCE el modelo teórico** que sustenta su desarrollo. El **modelo de base** permite **darle sentido a los puntajes obtenidos**".

- El **CAMPO DE ACCIÓN** del psicólogo educacional es **muy amplio**. Evalúa y analiza variables implicadas en la enseñanza-aprendizaje:

1. FACTORES DEL ESTUDIANTE

- Cómo **aprende**.
- Cómo se **motiva**.
- Desarrollo de **competencias**.
- **Regulación emocional**.
- **Ansiedad ante exámenes**.

2. FACTORES DEL DOCENTE

- Cómo **instruye**.
- Características que **favorecen la motivación y el aprendizaje**.
- Estilos **instruccionales**.
- Habilidades sociales en la **enseñanza**.

3. RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO

- **Interacción** entre ambos.
- **Vínculos** que **favorecen o dificultan** el aprendizaje.

4. FACTORES CONTEXTUALES

- Variables **asociadas al entorno escolar** (ej: bullying, cyberbullying).
- **Modalidades** de aprendizaje (individual vs. cooperativo).
- **Estrategias de enseñanza** que favorecen competencias y conocimientos.

5. CONDUCTA DEL ALUMNO

- Adaptación a **nuevos contextos académicos**.
- **Comportamientos** disruptivos.
- **Problemas** atencionales.

6. ORIENTACIÓN VOCACIONAL

- Evaluación de **intereses y aptitudes**.
- Ayuda en la **toma de decisiones** sobre la carrera a seguir.

Variedad de pruebas en Psicología Educativa

Existen **centenares de pruebas aplicables**, pero únicamente nos centramos en los **constructos más relevantes**. Tipos de pruebas comunes:

- **FACTORES MOTIVACIONALES** (ej: autoconfianza en exámenes).
- **ENGAGEMENT ACADÉMICO** (compromiso e identificación con los estudios).
- **APTITUDES E INTELIGENCIAS**: Modelos múltiples (Howard Gardner) o factor general de inteligencia (ej: WISC).

- **CONDUCTA Y ADAPTACIÓN** (ej: adaptación al contexto, problemas de atención).
- **ESTILOS INSTRUCCIONALES DEL DOCENTE.**
- **ORIENTACIÓN VOCACIONAL** (patrones de intereses y aptitudes).

Primer constructo a analizar: **MOTIVACIÓN ACADÉMICA**

Un **alumno puede tener aptitudes para aprender**, pero **SI CARECE DE MOTIVACIÓN, no logra sostener el proceso de aprendizaje**. La falta de motivación genera:

- DIFICULTAD para adquirir conocimientos.
- PROBLEMAS para desarrollar competencias.
- Posible ABANDONO frente a obstáculos.

Es un **constructo crítico** en el ámbito educacional y también laboral.

DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN:

- Concepto "paraguas" (umbrella): **engloba múltiples variables** que **INTERACTÚAN** y **SOSTIENEN** la **conducta**.

DEFINICIÓN GENERAL:

- "**ESTADO INTERNO** que **activa al organismo**, dirige el comportamiento hacia una **meta** y mantiene esa **conducta en el tiempo**".
- No es exclusiva de los humanos: también se observa en otros organismos.

< Ejemplo: Un animal que ejecuta una conducta con energía, dirección y persistencia se considera motivado.

Motivación intrínseca y extrínseca

Intrínseca:

- **Factores INTERNOS** (emocionales, cognitivos).
- La persona se **autorregula** para **sostener la conducta**.

< Ejemplo: Una persona que hace ejercicio porque disfruta la actividad

Extrínseca (incentivos):

- **Factores EXTERNOS** que activan, dirigen y mantienen la conducta.

< Ejemplo: Una persona que hace ejercicio por recomendación médica o para un objetivo externo (ej: estética)

Diferencia entre motivación y hábito

- **HÁBITO: conducta repetida que se AUTOMATIZA** y ya no requiere decisión (ej: lavarse los dientes).
- **MOTIVACIÓN: implica ESFUERZO Y ENERGÍA CONSCIENTE** para sostener la conducta en el tiempo, incluso frente a dificultades.

Componentes de la motivación

1. **Energía:** disposición de **recursos para ejecutar** la conducta.
- **DIRECCIÓN SIN ENERGÍA** → falta de sostén y abandono.

2. Dirección: orientación de la conducta hacia una meta específica.

- **ENERGÍA SIN DIRECCIÓN** → **conducta desordenada, dispersa**

< Ejemplo: Un estudiante puede estar **motivado a estudiar** (**dirección clara**), pero si está agotado y sin energía, **no logra sostener el estudio**.

Teorías de la motivación en Psicología Educacional

- Existen múltiples teorías que explican qué **variables influyen en la energía y dirección del comportamiento**.
- Una de las más estudiadas es la **TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DE LAS CARRERAS**.

La **teoría social cognitiva**, desarrollada por Albert Bandura, es una de las **más influyentes en la psicología contemporánea**.

- Bandura **planteó que el comportamiento humano se comprende mejor** a través de un modelo de **RECIPROCIDAD TRIÁDICA**, donde **interactúan** de manera constante **tres factores**:

1- **Factores personales** (creencias, interpretaciones, emociones, cogniciones).

2- **Factores ambientales** (contexto, recursos, docentes, pares).

3- **Factores conductuales** (las acciones concretas que realizamos).

En este modelo, **la conducta depende del AMBIENTE**, y **también de cómo los individuos INTERPRETAN y PROCESAN** cognitivamente los estímulos externos.

- Además, la conducta misma puede modificar el ambiente, generando un ciclo de influencia recíproca.

Aplicación al ámbito académico

Autores como Robert Lent **llevaron esta teoría al estudio** de la **MOTIVACIÓN Y PERSISTENCIA ACADÉMICA**. El planteo central es que los **estudiantes no son agentes pasivos**, sino **ACTIVOS**: sus **creencias, expectativas y conductas influyen** en cómo **atraviesan la experiencia universitaria**.

< Ejemplo: aunque los alumnos compartan el mismo contexto (aulas, docentes, planes de estudio), las conductas son diferentes:

- Algunos participan activamente y hacen preguntas.
- Otros prefieren mantenerse en silencio.

Esto se explica porque las **diferencias personales** moldean la forma en que cada uno **INTERPRETA y REACCIONA** al ambiente.

Dentro de este marco, se desarrolló el **MODELO DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA** (Lent, Brown y Hackett), es fundamental porque influye en:

- **Persistencia universitaria**: estudiantes más **satisfechos** tienden a **continuar sus estudios**.
- **Compromiso e involucramiento**: mayor **participación activa** en clases y actividades.
- **Rendimiento académico**: **mejores resultados** en términos de aprendizaje y calificaciones.
- **Bienestar psicológico**: estudiantes más satisfechos presentan **mayores niveles de bienestar general**.

Por el contrario, la **INSATISFACCIÓN ACADÉMICA** puede llevar a **abandono, bajo rendimiento o malestar psicológico**.

La **SATISFACCIÓN ACADÉMICA** se explica a partir de la **interacción entre factores emocionales y cognitivos**. Entre ellos destacan **tres variables "núcleo"** de la teoría social cognitiva aplicada a la educación:

a) Expectativas de resultados

- Son las **creencias** acerca de las **consecuencias de una conducta**.
- Si se **anticipan resultados positivos**, aumenta la probabilidad de **ejecutar la conducta**. (ej. "asistir a clases porque se espera aprender algo valioso".)
- En cambio, si se **anticipan consecuencias negativas** (ej. "no voy a entender nada"), **disminuye la motivación**.

b) Metas y progreso en metas

- **Funcionan como criterios internos** que **guían la conducta** y permiten **evaluar si lo que hacemos tiene sentido**.
- Cuando sentimos que avanzamos hacia nuestros objetivos, **aumenta la satisfacción**.
- Sin embargo, **metas poco realistas o excesivamente altas** (ej. perfeccionismo) pueden generar **frustración y desmotivación**, incluso frente a logros objetivos.

c) Autoeficacia:

- Hace referencia a la **creencia personal en la propia capacidad** para ejecutar conductas necesarias para alcanzar objetivos académicos.
- Es considerada un **factor central en la motivación, persistencia y desempeño**.

Se diferencian de la **CONFIANZA**, que suele ser más general.

La **AUTOEFICACIA** es **específica y micro-analítica**: un estudiante puede **sentirse muy capaz en ciertas materias** (ej. Lengua) pero **inseguro en otras** (ej. Matemática o Filosofía).

- Estas creencias **OPERAN CONSTANTEMENTE**, orientando qué **conductas realizamos y cuáles evitamos**.

Sesgos en la percepción de autoeficacia: **tendemos a SOBREESTIMAR nuestras capacidades futuras**.

< Ejemplo clásico: muchos estudiantes posponen rendir un examen pensando que en la próxima fecha estarán "el doble de preparados". Sin embargo, al llegar ese momento suelen encontrarse en la misma situación.

- Este **exceso de optimismo** puede llevar a **PROCRASTINAR, RETRASAR DECISIONES o EVITAR AFRONTAR DESAFÍOS**.

La autoeficacia influye de múltiples maneras:

1. **Elección de conductas:** Realizamos actividades en la medida en que nos sentimos capaces de hacerlas.

< Si un estudiante percibe que no puede aprobar un examen, probablemente ni siquiera se presente, aunque tenga las competencias objetivas para rendirlo.

2. **Compromiso y esfuerzo:**

- Estudiantes con **alta autoeficacia** frente a obstáculos suelen **aumentar el esfuerzo** ("redoblar la apuesta").

- Estudiantes con **baja autoeficacia**, ante la misma dificultad, **tienden a reducir el compromiso o abandonar**.
3. **Atribuciones del fracaso**
- **Alta autoeficacia**: atribuyen **fracasos a factores transitorios y modificables** (ej. falta de estudio, examen difícil).
 - **Baja autoeficacia**: atribuyen **fracasos a factores internos, estables y globales** ("no sirvo para esto", "soy incapaz"), lo que **disminuye la motivación y la autoestima**.
4. **Manejo de recursos cognitivos**
- Con **igual nivel de conocimientos**, quienes tienen **MAYOR AUTOEFICACIA** suelen **utilizar mejor lo que saben**, mientras que los de **BAJA AUTOEFICACIA** pueden **bloquearse por la ansiedad** y rendir por debajo de sus capacidades reales.

En conjunto, la autoeficacia predice **MAYOR rendimiento académico, MEJORES calificaciones y DESEMPEÑO sostenido**.

Es importante evitar los extremos:

Autoeficacia demasiado BAJA → desmotivación, abandono, autopercepción negativa.

Autoeficacia excesivamente ALTA → conductas de riesgo y sobreestimación peligrosa (ej. creer que se puede manejar en estado de ebriedad).

LO MÁS SALUDABLE: niveles de autoeficacia ligeramente **superiores a las capacidades reales**, porque eso **impulsa a enfrentar desafíos y crecer**.

Rol del docente y feedback

El **FEEDBACK docente** juega un **papel decisivo**:

- **Señalar errores es necesario**, pero debe hacerse **preservando la autoeficacia del estudiante**.
- Lo recomendable es **presentar las dificultades** como **aspectos transitorios y mejorables**, y fomentar **experiencias de éxito** que refuercen la creencia de que **"se puede lograr"**.

Instrumento de evaluación: el sistema CESA

Para **operacionalizar estas ideas**, se desarrolló el **CESA (SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA)**

- Este instrumento **permite evaluar de manera rápida y masiva variables** clave como:

Satisfacción académica – Autoeficacia - Metas y progreso en metas - Expectativas de resultados - Apoyos percibidos

Objetivos del CESA:

- **MONITOREAR** el **desarrollo motivacional de los estudiantes**, especialmente **INGRESANTES**.
- **DETECTAR** tempranamente **estudiantes en riesgo** (baja autoeficacia, baja satisfacción, baja percepción de progreso).
- **OFRECER** apoyo personalizado para **prevenir el abandono y fortalecer la permanencia universitaria**.

EVALUACIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL

La **evaluación en orientación vocacional** es un **campo amplio** y en **permanente actualización**.

- Existen **centenares de pruebas** que **pueden utilizarse**, aunque en la **práctica se destacan algunas herramientas** particularmente **influyentes y adaptadas al contexto educativo**.

La **evaluación vocacional** NO SE REDUCE A LA APLICACIÓN DE TEST PSICOMÉTRICOS. Es un **proceso integral**, en el que los **resultados de las pruebas se combinan** con **ENTREVISTAS, REFLEXIÓN PERSONAL, ANÁLISIS DE CONTEXTO** y **ACOMPANIAMIENTO PROFESIONAL**.

Dentro de este campo, **dos variables se consideran fundamentales** para comprender y acompañar la elección de una carrera:

1. Autoeficacia: predice el desempeño.
 2. Intereses vocacionales: predice la satisfacción.
- Refieren al **agrado o desagrado** hacia distintas actividades.

Un aspecto muy destacado es la existencia de **instrumentos de evaluación creados en nuestro contexto**, en particular en la **Universidad Nacional de Córdoba**. Entre ellos se destacan:

1. **INVENTARIO DE AUTOEFICACIA PARA INTELIGENCIAS MÚLTIPLES** (IAIM o JAM)
 - Desarrollado por Edgardo Pérez, basado en la **teoría social cognitiva** de Bandura y la **teoría de las inteligencias múltiples** de Howard Gardner.

Evalúa la **AUTOEFICACIA PERCIBIDA** en **ocho dominios de comportamiento** vinculados a distintos tipos de inteligencia:

- Lingüística
- Lógico-matemática
- Espacial
- Corporal-kinestésica
- Musical
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Naturalista

2. CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES (CIP)

- Creado por Hermelinda Fegoliatto junto a Edgardo Pérez.
- Se centra en los **INTERESES VOCACIONALES** y fue **diseñado específicamente** para la **POBLACIÓN ARGENTINA**.

El **estudiante responde a diferentes actividades** indicando si le resultan **AGRADABLES, INDIFERENTES** o **DESAGRADABLES**.

- Mediante **ANÁLISIS FACTORIAL**, los ítems se agrupan en **escalas asociadas a distintos campos profesionales**, como:

Arte - Empresa – Enseñanza – Música – Cálculo – Salud - Naturalistas, entre otros.

3. SISTEMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL INFORMATIZADO (SOVI)

- Herramienta informática que integra los **dos instrumentos anteriores**: el **IAIM (JAM)** y el **CIP**.

Los estudiantes **completan ambos cuestionarios** y el sistema **cruza la información**, generando un **perfil que combina**:

- AUTOEFICACIA EN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
- INTERESES VOCACIONALES

Autorregulación del Aprendizaje

La **investigación en educación** se centraba en el **ROL DEL DOCENTE**: se asumía que **los logros del estudiante** dependían de lo que el profesor hacía o dejaba de hacer en el aula.

- Este enfoque veía al alumno como un **sujeto reactivo y pasivo**.

En los últimos años, este **paradigma cambió** en la que el **estudiante es un AGENTE PROACTIVO** y **DUEÑO DE SU PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE**.

Aprender a lo largo de la vida

El **contexto actual** exige que las **personas continúen aprendiendo** incluso **DESPUÉS DE GRADUARSE**.

- El **conocimiento** se **transforma y actualiza constantemente**.
- El **aprendizaje** ya no es un proceso que termina en la escuela o en la universidad, sino que **se extiende durante toda la vida** (lifelong learning).

En muchos casos, las **dificultades académicas** no se deben a falta de capacidad intelectual, sino a **FALLAS EN LA AUTORREGULACIÓN** (p. ej., mala planificación, procrastinación, estudio superficial)

Existen diversos **tests e instrumentos psicométricos** para **MEDIR LA AUTORREGULACIÓN**:

- **IDAP (INVENTARIO DE AUTOEFICACIA PARA LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE)**:

Desarrollado en Argentina.

Evalúa la **autoeficacia** (creencia de poder autorregularse).

Especialmente **útil en nivel medio**.

- **MSLQ (MOTIVATED STRATEGIES FOR LEARNING QUESTIONNAIRE)** y **SELF**:

Miden **estrategias de aprendizaje, motivación** y diferentes **variables asociadas al proceso autorregulatorio**.

Uno de los **modelos más influyentes** es el de **ZIMMERMAN**, que plantea **tres fases fundamentales** en el proceso de autorregulación:

a) **FASE DE PLANIFICACIÓN**

- Implica **organizar y anticipar** cómo se va a **llevar adelante el estudio**.
- Incluye: establecimiento de **metas**, elaboración de **cronogramas** y **rutinas**, selección de **estrategias**.
- **Variables críticas**: Metas claras y realistas. Agenda de estudio. Autoeficacia y creencias de control.

b) FASE DE EJECUCIÓN

- Consiste en **llevar a cabo lo planificado**.
- Riesgos frecuentes: **procrastinación** y **estrategias superficiales** de estudio.
- Estrategias recomendadas: Mantener **disciplina** y **evitar la postergación**. Utilizar un **estudio profundo y significativo**, más allá de la memorización. Favorecer la **comprensión**, **elaboración y organización de ideas** (ej. resúmenes, mapas conceptuales, esquemas).

c) FASE DE AUTOMONITOREO Y AUTORREFLEXIÓN

Supone **evaluar de manera constante** el propio proceso:

- ¿Estoy cumpliendo con lo planificado?
- ¿Qué dificultades aparecen?
- ¿Necesito pedir ayuda o ajustar mi estrategia?

La automonitoreo **evita que los problemas se detecten recién en el examen**.

Incluye la capacidad de **ajustar la planificación** y de **reconocer avances y logros**.

La **autorregulación del aprendizaje** es una **COMPETENCIA CENTRAL** en la educación actual:

- Permite **afrontar con éxito** los **desafíos académicos universitarios**.
- Garantiza la **capacidad de aprender de manera autónoma** a lo largo de toda la vida.
- Su **evaluación y desarrollo son objetivos** clave dentro de la psicología educativa.

EVALUACION EN PSICOLOGIA CLINICA

En **Argentina**, la **evaluación clínica** suele estar muy asociada a:

- **ENTREVISTAS CLÍNICAS**.
- **PRUEBAS PROYECTIVAS**.

A nivel **Internacional**, las **pruebas psicométricas** tienen gran relevancia.

- La entrevista clínica es **IRREMPLAZABLE**.
- Las pruebas psicométricas y proyectivas son **COMPLEMENTOS VALIOSOS**, no sustitutos.

El Proceso de Evaluación Clínica: Es **INTEGRAL Y MULTIMÉTODO**, combina:

- Entrevistas clínicas.
- Pruebas psicométricas y proyectivas.

Objetivos:

- **Obtener información válida y confiable**.

Permitir:

- **Diagnóstico**.
- **Planificación** del tratamiento.
- **Seguimiento** de la evolución del paciente.

Tipos de Pruebas Psicométricas

a) PRUEBAS DE CRIBADO / SCREENING

Definición: Instrumentos breves que **detectan tempranamente RIESGO o PROBABILIDAD de un trastorno.**

Objetivo: Identificar **quién necesita evaluación clínica** más profunda.

- Fáciles y rápidas de aplicar.
- Se basan en puntos de corte.
- No son diagnósticas.

< Ejemplo: PHQ-4 (versión breve que evalúa síntomas de depresión y ansiedad).

b) PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Definición: Instrumentos que permiten un **análisis detallado de un trastorno.**

Objetivo: **Confirmar diagnóstico y planificar** tratamiento.

- Conceptualizar el caso (factores de origen, de mantenimiento y características personales).
- Evaluar severidad y evolución.
- Ajustar el plan terapéutico.

< Ejemplo: Inventario de Depresión de Beck (BDI).

c) PRUEBAS DE BIENESTAR PSICOLÓGICO

Definición: Instrumentos que **evalúan el polo positivo de la salud mental.**

Objetivo: Medir **bienestar, calidad de vida, satisfacción y autodesarrollo.**

< Ejemplo: Escala BIEPS (Argentina).

Idea clave: **NO TENER un trastorno ≠ TENER BIENESTAR psicológico.**

Ventajas del Uso de Pruebas Psicométricas

- **COMPLEMENTAN LA ENTREVISTA** → Evitan **pasar por alto** aspectos importantes.
- **VALIDEZ Y CONFIABILIDAD** → Están **estandarizadas** y con **respaldo científico.**
- **FACILITAN COMUNICACIÓN ENTRE PROFESIONALES** → Muy **útiles en informes** judiciales, interconsultas y derivaciones.
- **APORTAN DATOS OBJETIVOS** sobre **diagnóstico, severidad y perfil del paciente.**
- **ANTICIPAN RIESGOS** → Ejemplo: alta desesperanza → riesgo suicida.
- **MIDEN EFICACIA DE INTERVENCIONES** → Comparan pre-tratamiento y post-tratamiento.

Evidencia: **psicólogos que combinan ENTREVISTAS + PRUEBAS** logran diagnósticos más **certeros y mejores planes de tratamiento.**

Problemas Actuales en la Detección de Trastornos

1. **Subdiagnóstico:** muchas personas con **síntomas no son detectadas** en atención primaria.
2. **Automedicación y abuso de fármacos:**
 - **Aumento en ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos.**
 - Problema: **alivio sintomático sin resolver la causa** → recaídas.
 - Mejor opción: **combinación de psicoterapia + farmacoterapia** (cuando es necesaria).
3. **Confusión conceptual:**

- **ENFERMEDAD** = causada por un **agente patógeno** (ejemplo: gripe por virus).
- **TRASTORNO** = **procesos psicológicos/emocionales normales** que se vuelven crónicos e intensos, afectando funcionalidad.

Ejemplos:

< Tristeza normal → Depresión si persiste y limita la vida.

< Ansiedad adaptativa → Trastorno de ansiedad si es desproporcionada e incontrolable.

< Alegría excesiva → puede indicar manía.

Proyecto PsicAP (España)

- Desarrollado por la Universidad Complutense y Valencia.

Objetivo: **DETECTAR PRECOZMENTE trastornos emocionales** en atención primaria.

Estrategia: **aplicar pruebas breves de screening** para **evitar que síntomas LEVES se vuelvan GRAVES.**

Principales Pruebas de Screening

a) PHQ (Patient Health Questionnaire)

- Evalúa varios **trastornos emocionales**.
- Sus módulos más usados:

PHQ-9 → Depresión

- 9 ítems.
- Punto de corte ≥ 12 .
- Evalúa tristeza, anhedonia, fatiga, concentración.
- Riesgo: falsos positivos → confirmar con entrevista.

GAD-7 → Ansiedad generalizada

- 7 ítems.
- Evalúa preocupación excesiva, tensión física, insomnio.

PHQ-PD → Trastorno de pánico

- Dos fases: detección inicial y profundización.
- Identifica ataques de pánico.

Pruebas Diagnósticas y de Severidad

A- TRASTORNOS DE ANSIEDAD

- **Inventario de Temores** (122 ítems) → **Evalúa fobias** (poco usado hoy).
- **Cuestionario de Miedos** (24 ítems) → **Fobias comunes** (10 min).
- **Inventario de Ansiedad Social** (33 ítems) → **Miedo a la evaluación negativa**.
- **Inventario de Preocupación de Pensilvania** (16 ítems) → **Preocupación excesiva, típica de ansiedad generalizada**.

B- TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO: DEPRESIÓN

- **Escala de Hamilton** (24 ítems, entrevista estructurada) → **muy usada clínicamente**.

- **Inventario de Depresión de Beck (BDI)** (21 ítems, autoinforme) → **evalúa cognitivo, conductual y emocional.**
- **Escala de Desesperanza de Beck** (20 ítems) → **Expectativas negativas sobre el futuro, predictor de riesgo suicida.**

Evaluación del Bienestar Psicológico

A- Psicología Positiva: Surge en 1998 con Martin Seligman.

- Propone equilibrar el estudio de: Factores de **riesgo**. Factores que **promueven el bienestar.**

B- Tradiciones del Bienestar

- **Hedónica** → balance entre **emociones positivas y negativas.**
- **Eudaimónica** → **autorrealización, propósito vital, crecimiento personal.**

Hoy se integran ambas:

EMOCIONES (hedónico) Y **SATISFACCIÓN VITAL Y PROPÓSITO** (eudaimónico).

C- Componentes principales

Balance emocional. **Satisfacción** con la vida. **Autodesarrollo** y propósito vital.

D- Instrumentos

PANAS → emociones positivas y negativas.

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (DIENER) → satisfacción vital.

MODELO DE RYFF → 6 dimensiones de bienestar.

ESCALA BIEPS → versión argentina, muy usada en Iberoamérica.

Ideas Clave para Recordar

- La **EVALUACIÓN CLÍNICA** debe ser integral: **entrevistas + pruebas.**
- **SCREENING** → **detecta riesgo, no diagnóstica.**
- **BIENESTAR PSICOLÓGICO** → **ausencia de trastorno ≠ salud mental.**

EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

Usos principales de los tests psicométricos en las organizaciones

Existen **dos grandes áreas de aplicación:**

1. SELECCIÓN DE PERSONAS

- Identificar al **candidato más adecuado** para un puesto.
- Evaluar aptitudes, competencias, personalidad y **ajuste al perfil buscado.**

2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- Intervenciones en **clima organizacional** y **satisfacción laboral.**
- **Medición** y **prevención** del **estrés laboral.**
- Aumento de la **productividad y desempeño de equipos.**
- Evaluación del **bienestar psicológico y salud mental.**

Además, los tests se usan en:

- **Planes de desarrollo y carrera.**
- **Evaluación de talento.**
- **Gestión de equipos de alto rendimiento.**

Enfoque actual: Bienestar psicológico como inversión organizacional

Las **empresas reconocen** que **MAYOR BIENESTAR** de los trabajadores = **MAYOR PRODUCTIVIDAD**.

Bienestar se relaciona con:

- **OPTIMISMO.**
- **CONFIANZA** en las propias capacidades y en el equipo.
- **CLIMA LABORAL** positivo.

Incluso, en **varios países ya existen leyes que obligan a las organizaciones** a **promover el bienestar psicológico** de los trabajadores.

Variables centrales en la evaluación psicométrica organizacional

1- **BURNOUT**: **síndrome de estrés crónico laboral.**

- Surge cuando existe **desequilibrio** entre **demandas y recursos** disponibles.
- No es malo el **ESTRÉS AGUDO** (*ocasional, con recuperación*), el **problema es el ESTRÉS CRÓNICO** (*sostenido en el tiempo*).

Síntomas principales:

- **Agotamiento emocional** → cansancio persistente, falta de energía, sensación de no recuperarse.
- **Cinismo o despersonalización** → distanciamiento psicológico del trabajo, pérdida de interés, indiferencia hacia la tarea.
- Reconocido por la **OMS COMO TRASTORNO**.

2- **ENGAGEMENT**: **estado motivacional positivo y persistente** en el trabajo.**

- Se considera el **polo opuesto al burnout**.

Dimensiones:

- **VIGOR** → **altos niveles de energía** y persistencia ante obstáculos.
- **DEDICACIÓN** → **fuerte identificación con el trabajo**, orgullo, propósito.
- **ABSORCIÓN** → sensación de **fluidez y concentración total** en la tarea (aunque en Argentina se recomienda medir solo vigor + dedicación).
- El **ENGAGEMENT PREDICE PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR**.

Instrumentos más utilizados

♦ Para Burnout

- **MBI (Maslach Burnout Inventory)**
 - Mide **agotamiento emocional** y **cinismo**.
 - Validado en Argentina con buenos niveles de confiabilidad (> .70).

♦ Para Engagement

- **UWES (Utrecht Work Engagement Scale)**

- Evalúa **vigor, dedicación y absorción** (aunque en Argentina se recomienda la versión de dos factores: vigor + dedicación).
- Alta confiabilidad (> .80).

Relación BURNOUT ↔ ENGAGEMENT

- Representan **dos polos de un mismo proceso**.
- Una **persona puede moverse de un polo a otro** dependiendo de **demandas, recursos y recuperación**.
- **Estudios con cortisol** (hormona del estrés) demostraron:

ENGAGEMENT → **bajos niveles de cortisol**.

ESTRÉS CRÓNICO (BURNOUT) → **patrones alterados de cortisol**.

Existen **fases intermedias** útiles para **diseñar intervenciones preventivas**.

Factores predictores del Burnout y Engagement

1. Emociones

- **Emociones negativas** → predicen **BURNOUT**.
- **Emociones positivas** → predicen **ENGAGEMENT** y protegen contra burnout.

2. Autoeficacia profesional

- Creencia en la **propia capacidad para afrontar demandas laborales**.
- **MAYOR AUTOEFICACIA** → **MENOS burnout** y **MÁS engagement**.

3. Estilos de liderazgo (medidos con la escala MLQ – **Multifactor Leadership Questionnaire**)

- **Laissez-faire** → ausencia de liderazgo, perjudicial.
- **Transaccional** → basado en premios/castigos, limitado.
- **Transformacional** → comunica propósito, inspira, apoya individualmente y fomenta innovación.

Se asocia a **MAYOR ENGAGEMENT Y MENOR BURNOUT**.

Aplicaciones prácticas en las organizaciones

- **Evaluación del clima laboral.**
- Diseño de **políticas de bienestar y prevención del estrés**.
- Capacitación de **líderes en estilos transformacionales**.
- **Identificación de perfiles de riesgo** (trabajadores sobreexigidos, con cinismo, etc.).
- Fomento de **emociones positivas y fortalecimiento de la autoeficacia**.